06. LE COEUR INTRODUCTION ET ORIGINES

DURÉE : 11:43 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo propose une introduction approfondie sur le rôle central du cœur dans le développement embryonnaire. Le cœur, qui commence à battre dès le 21e jour de la vie intra-utérine, joue un rôle crucial dans la distribution de l'information, influençant le tube neural et le système digestif via des mécanismes autocrines et paracrines. L'interdépendance entre le cœur de l'enfant et la santé de la mère est également abordée, soulignant que les enfants sont énergétiquement liés à leur mère jusqu'à l'âge de 7 ans, moment important de leur développement. On explore aussi les origines primitives du cœur, sa position asymétrique et les polarités établies dès la fécondation, illustrant ainsi l'interaction complexe entre la biologie et l'embryologie, et comment cela influence la santé future de l'individu.

LE CŒUR : INTRODUCTION ET ORIGINES

LE CŒUR, MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Votre **cœur** commence à battre au **21e jour** de la vie intra-embryonnaire. Après trois semaines, c'est le premier système à fonctionner et il maintiendra cette fonction toute sa vie : la **distribution de l'information**.

Dès que le cœur bat, le processus de **croissance** s'accélère. Le premier à recevoir cette grande information du cœur est le **tube neural**, l'ensemble du cerveau.

C'est le cœur qui est le moteur, celui qui va aspirer. Il existe une relation très importante et fonctionnelle entre le cœur et le cerveau. C'est le cœur qui va donner la force au cerveau.

Des études ont montré que dans le **système ventriculaire profond**, il existe une vibration pulsatile directe du cœur qui informe le cerveau. Il y a un lien direct, à des niveaux très subtils.

LE CŒUR ET LA DISTRIBUTION DE L'INFORMATION

Le cœur distribue l'information. Mais quelle information ? Il distribue la **"nourriture"**, en étroite relation avec le **système digestif** et le lien avec la mère.

Vous amenez une information trophique organisée par votre cœur et redistribuée par votre système. Vous êtes donc dépendant de votre **endoderme**, de votre système digestif, dans votre développement.

Autocrine, **paracrine**, digestif, et ce n'est qu'ensuite que le système apparaît visiblement.

LE CŒUR DE L'ENFANT ET LE LIEN MATERNEL

Lorsque nous travaillons sur ce lien avec un enfant, il est souvent nécessaire de soigner la **maman**. Si la maman n'est pas libre dans sa fonction, l'enfant ne peut pas se libérer non plus, car il sera dépendant énergétiquement, au minimum jusqu'à **7 ans**.

Sur le plan énergétique cellulaire, toutes les cellules de votre corps sont renouvelées à 7 ans. C'est ce qu'on appelle **"le nouveau corps"**. C'est sa première naissance, le moment où il peut avoir **"la raison"**.

C'est le moment où son **sinus frontal** s'ouvre et que sa **thyroïde** devient complètement électrique, car elle a réinformé son cœur. C'est pourquoi on peut sentir le cœur à distance.

Il est informé par la **crête neurale** et a transmis son information. À 7 ans, l'enfant peut se défendre dans son environnement, il trouve sa première indépendance.

ORIGINE PRIMITIVE DU CŒUR

L'ébauche du cœur apparaît dans le **mésoblaste splanchnopleural**, sur un plan primitif. De nouveau, il sera dépendant de tout le **système vitellin**.

On retrouve ici une force présomptive du cœur avant la **gastrulation** et avant le plan vasculaire, le long des cellules **cardiogéniques** de l'épiblaste. Il a déjà tout son champ du possible.

Quand je prends un **sacrum** ou un **coccyx** et que je me mets dans le système, j'ai déjà l'histoire du cœur qui se présente. Donc, je dois commencer à traiter le cœur en commençant par libérer la **ligne primitive**, sous cette première vague qui se développe.

RUPTURE DE SYMÉTRIE ET POSITION DU CŒUR

La rupture de la **symétrie** se fait dès la mise en place du processus **notochordal**. Il y a un flux nodal avec des petits cils qui amènent des vésicules cérébrales de la droite vers la gauche, via la sonétique **HH**, le **FGH8**, et finalement un changement d'acide **rétinoïque**.

Ceci induit un changement sur le plan **calcique** qui donne une intégration différente dans l'information génétique. Au bout du compte, il y a une rupture de la symétrie de la droite vers la gauche, où une information importante est donnée à ce niveau.

Cette rupture de la symétrie sera un des facteurs qui positionnera le cœur vers la gauche dans le futur. Cela se fait par des **molécules morphogénétiques**, avec une augmentation du taux calcique sur toute une lame latérale, et donc toute l'information de l'intégration génétique sera

différente.

Cette asymétrie se fait entre la base du crâne et le sacrum, avec la ligne primitive. La déviation est présente : c'est un flux qui vient de la droite vers la gauche.

POLARITÉ ET IMPACT DU SPERMATOZOÏDE

Cela se retrouve à un autre niveau par les **cellules nourricières folliculaires** qui libèrent des enzymes. Elles créent déjà une **polarité** au sein de l'ovocyte, dans le cytosquelette.

Une première polarisation se fait sur un plan **crânio-caudal** et **dorsoventral**, même si l'ovocyte n'est pas encore informé de son environnement extérieur.

On constate que le lieu de pénétration du **spermatozoïde** va donner une réinformation dans l'axe longitudinal de l'embryon, où cette force présomptive sera créée.

Cette intégration est déjà une information de l'extérieur par la force du spermatozoïde qui restructure la force du cytosquelette sur un plan presque **électromagnétique**. Certains décrivent que cela se retrouve dans la partie apicale de l'embryon.

Cela signifie que l'on attrape un champ présomptif d'information. Et c'est dans ce champ présomptif que l'on va retrouver la future phase **cardiogénétique**.

Le spermatozoïde représente déjà, d'une certaine façon, la force cardiaque, la pulsation qui se prépare là. Mais il n'y a pas encore de forme ici, c'est une préforme.

ORGANISATION DE L'EMBRYON ET FORMATION DU CŒUR

On va voir très vite que toute une organisation de l'embryon va se développer avec la fameuse **"ola"**, avec un point d'appui ici, et un point d'appui là, avec la ligne primitive, et avec la réintégration de ce système.

L'importance de ces points est cruciale. Le deuxième point sera le moment où j'ai la vague, c'est-à-dire le passage de la mise en place de ma **troisième chambre embryonnaire**, le **cœlome** ou le **léciteux cellexterne**.

Cela va réorganiser l'embryon et créer une structure en forme de **S**. C'est à ce moment-là que j'aurai l'intégration par rapport au point d'attache, et c'est ce qui donne ma ligne primitive. Dans un embryon, le cœur est là.

LE CŒUR, LE PÉRICARDE ET LE DIAPHRAGME

Le cœur a trouvé sa place, il a intégré le **péricarde** et le **septum transversum**, avec ces **piliers diaphragmatiques** qui deviendront un point d'appui pour le système cardiaque.

Traiter un cœur, c'est libérer le diaphragme, puisque c'est son orientation qui fait cela. Le diaphragme devient vraiment notre outil thérapeutique, puisque les cellules péricardiques sont les mêmes cellules qui se retrouveront sur le plan du septum transversum, c'est-à-dire du diaphragme.

D'où prennent-elles leur origine ? J'ai mon cœur, et là j'ai des petites cellules **mésenchymateuses** qui formeront mon diaphragme. L'ectoderme grandit à fond, et cela se balance, et va former tout ce système-là.

L'IMPACT DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA FERTILITÉ

Le spermatozoïde arrive, et la **"clé"** est là pour la rencontre. La pilule a tué le concept, la possibilité de conceptualiser. On a coupé le système hormonal pendant des années.

De plus en plus de femmes ont des difficultés à concevoir. Un niveau médical est intervenu en disant : "Maintenant, nous pouvons vous aider." On fait ce qu'on appelle des **"IMSI"**, où l'on prend une aiguille, pique et traverse la membrane.

On espère être au bon endroit par rapport à la polarité. Sauf qu'on n'a pas la première reconnaissance, qui est une reconnaissance membranaire, coronarienne, tissulaire, moléculaire.

Probablement, ces enfants auront de plus en plus de problèmes de fertilité. Donc, ils ne sauront plus se reproduire ni se reconnaître. On a enlevé la première reconnaissance.

Ces enfants qui viennent en consultation, il faut les reconnaître. Les reconnaître à quel niveau du corps ? Leur cœur. Il faut les contacter par le regard dans leur cœur.

Si vous le faites, l'enfant le sait. C'est la seule chose que vous pouvez donner. "Je peux te reconnaître, te refaire naître." Sinon, ces personnes seront en recherche toute leur vie.

PUISSANCE MÉTABOLIQUE ET DÉVELOPPEMENT INITIAL

Cela se passe déjà dans votre **système vasculaire primitif**, au cinquième ou sixième jour. Le **zygote** doit avoir une puissance métabolique dans un pôle spécifique.

Le **trophoblaste cellulaire** doit se transformer en **syncytiotrophoblaste**. Ce syncytiotrophoblaste a une activité lytique pour pouvoir pénétrer la muqueuse. Si l'embryon n'a pas cette puissance, il ne peut pas entrer dans la muqueuse.

Deuxième chose, il faut que la mère soit accueillante. Mais ce n'est pas elle qui fait le travail pour l'embryon. A-t-il reçu cette puissance ?

Sa puissance métabolique est déterminée d'abord par une phase de **dédifférenciation cellulaire**. Pendant les trois, quatre premiers jours, le zygote ne grandit pas.

Par contre, il augmente sa **division cellulaire**, au clivage, à grande vitesse. Il y a une augmentation globale de la membrane, et une petite perte d'eau à l'extérieur.

C'est là qu'il va créer cette première cavité qu'on appelle **"germe du ciel"**, le **blastocèle**, qui est une connexion spécifique de votre **"ciel extérieur"**.

Ensuite, au niveau cellulaire, il y aura une augmentation de la membrane. Si la membrane augmente, les échanges augmentent. Les membranes sont des espaces d'échanges, toujours polarisés.

Si j'ai une cellule, j'ai un noyau, et je vois que mon noyau est concentré. C'est ici que j'ai ma plus grande force d'échanges. Au lieu d'en avoir 50, je vais en avoir 3000.

Les cellules dans cette phase de division deviennent **200 fois plus petites** que les deux blastomères originaux. Relativement, ma membrane augmente.

Si je prends ma membrane par rapport à mes deux premiers blastomères, on va dire que ça fait 100 mètres. Si je prends toutes ces petites membranes, j'augmente énormément.

J'augmente ma puissance métabolique. Si j'ai une puissance métabolique suffisante, j'ai une force suffisante pour entrer.

LA PUISSANCE MÉTABOLIQUE POUR LA VIE

Cette puissance métabolique, j'en aurai toujours besoin, toute ma vie. C'est un peu la **"pile"** que vous allez recevoir. Et vous devez faire confiance à cela.

Elle se régénère jusqu'à un certain temps par votre **sommeil**, votre **alimentation**, votre **respiration**, vos justes pensées, etc. Vous la dégénerez si vous ne respectez pas cela et si vous êtes intoxiqué.

Vous perdez vos substrats fondamentaux de cette puissance. Donc, vous avez besoin de cela. Le cœur prend son origine pratiquement dans le contact du spermatozoïde, dans cette rencontre, de façon symbolique.

Après, on la retrouve au niveau de la ligne primitive. Puis, une information déjà des champs cardiaques qui se font ici en rapport avec la présence d'un œdème sain, c'est dans la vague de croissance du développement des champs cardiaques.

Et puis on va voir une chose qui est très importante, c'est tout ce mouvement développemental.

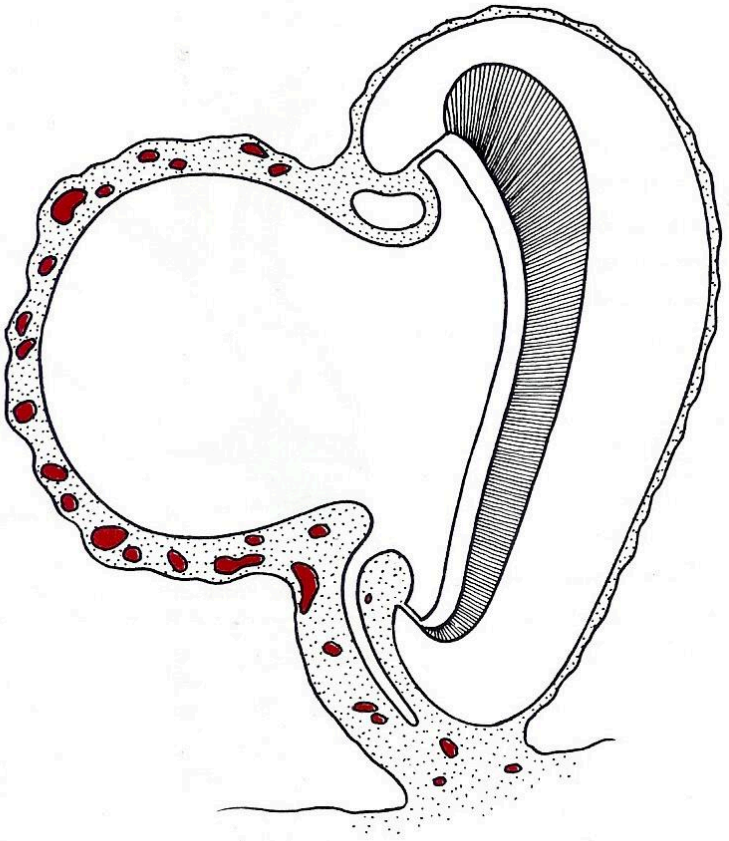


Fig. 1. — *Schéma d'un embryon humain de 3 semaines.*

FIG. — Embryon humain 3 semaines